# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81846
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-03 11:35:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | : BENEDICTO VASQUEZ MUNOZ | | | **RUN** | : 3.702.279-9 |
| **F.Nac** | : 04-12-1933 | **Edad** | : 90 AÑOS, 3 MESES | **Género** | : Masculino |
| **Dirección** | : LAS ROSAS CACHAPOAL | | | **Comuna** | : SAN CARLOS |
| **Previsión** | : FONASA B | **Teléfono** | : 0 | | |
| **Fecha Ingreso** | : 2024-03-27 | **Fecha Egreso** | : 2024-04-03 11:35:00 | **Causal** | : MEDICA |
| **Condición** | : VIVO | **Destino** | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | **Derivación** | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnosticos
-Neumonia Comunitaria Resuelta
-LRA Kdigo 2 multifactorial no oligurica Sobre ERC III (crea basal 1.4-1.6) --- resuelta
-Hipernatremia por deficit de liquidos/ uso de diureticos, en resolucion.
-ICC FeR Compensada
-Hipertension Arterial
-Fibrilacion Auricular en DOAC
-DM2NIR

Medicamentos
RIVAROXABAN 20MG C/24H, BISOPROLOL 5MG C/24H, ESPIRONOLACTONA 25MG C/24H, ATORVASTATINA 40MG C/24H. FUROSEMIDA 40MG CADA 12

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE MASCULINO CON ANTECEDENTES DE HTA SISTEMICA, FA EN NACO, DMNIR QUIEN REFIERE INICIO DE CUADRO CLINICO HACE 1 SEMANA CARACTERIZADO POR INCREMENTO DEL PATRON DE DISNEA, DESATURACION Y COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL POR LO QUE ES TRAIDO AL SU HSC DONDE SE VALORA ENCONTRANDO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES, TAQUIPNEICO, SOLICITAN LABORATORIOS DONDE DESTACA PARAMETROS INFLAMATORIOS MODERADAMENTE ALTOS, REALIZAN RX TORAX DONDE DESTACA CARDIOPATIA DILATADA E IMAGEN HIPODENSA CON TENDENCIA A CONSOLIDACION EN HEMITORAX DERECHO POR LO QUE POSTERIOR A EVALUACION SE INGRESA CON DIAGNOSTICO DE NEUMONIA.
SE MANEJA CON OXIGENOTERAPIA , TRATAMIENTO ANTIBIOTICO CON CEFTRIAXONA Y AZITROMICINA CON LENTA RESPUESTA PERO HACIA LA MEJORIA.
DESARROLLA FALLA RENAL AGUDA DESCRITA QUE LENTAMENTE REGRRSA A CREATININA BASAL, ACTUALMENTE EN 1.5 CON HIPERNATREMIA LEVE PRODUCTO DE USO DE DIURETICOS Y RESTRICCION HIDRICA.
ACTUALMENTE CON NA 148 PERO TOTALMENTE ASINTOMATICO.

COMPLETA 9 DIAS DE CEFTRIAXONA Y 5 DE AZITROMICINA CON PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA Y SIENDO COMPLETAMENTE DESTETADO DEL OXIGENO EL DIA 1.4.24
ACTUALMENTE SE MANTIENE CON NECESIDADES DE KINE RESPIRATORIA Y MOTORA POR LO CUAL SE DECIDE TRASLADO A HODOM PARA CONTINUAR CON MANEJO KINESICO Y CONTROL IGUALMENTE DE CREATINIA Y SODIO PLASMATICO EN 48 HORAS POST ALTA.

EXAMEN FISICO AL ALTA.
PA 118/79 FC 79X SAT 94 AMBIENTAL FR20X SIN APREMIO RESPIRAOTRIO.
VIGIL TRANQUILO COOPERADOR.
BIEN PERFUNDIDO
RI2T
MP+ ESCASOS SIGNOS OBSTRUCTIVOS. SIN CREPTIOS
ABDOMEN BDI
EEII SIN EDEMAS

## PLAN DE MANEJO:

PLAN AL ALTA POR HODOM.
-KINESIOTERTAPIA MOTORA Y RESPIRATORIA
-CONTROL EN 48 HORAS CREATININA PLASMATICA + ELECTROLITOS.
-SE SUSPENDE DIURETICOS DE ASA

## INDICACIONES AL ALTA

1. INDICACIONES
2. -REGIMEN HIPOSODICO.
3. -REPOSO RELATIVO.
4. -REANUDAR TRATAMIENTO CRONICO
5. ---RIVAROXABAN 20MG C/24H, BISOPROLOL 5MG C/24H, ESPIRONOLACTONA 25MG C/24H, ATORVASTATINA 40MG C/24H.
6. ---FUROSEMIDA DISMINUYO LA DOSIS A 1/2 COMPRIMIDO AL DOA.
7.
8.
9. -IPRATROPIO 4 PUFF CADA 8 HORAS POR 15 DIAS MAS.
10. -KINESIOTERAPIA MOTORA Y RESPIRATORIA.
11. -CONTROL CREATINIA Y ELECTROLITOS EL VIERNES 5.4
12. -CONTROL URGENCIAS SOS.

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO